

AI 진단 보조 리포트

환자: 이환자 | 나이: 42세 | 성별: M

방문일: 2026-05-06 | 방문유형: 응급실

주호소: 갑작스럽고 찢어지는 듯한 가슴 통증과 호흡곤란 (Chest pain & Dyspnea)

1. 임상 요약

42세 남성이 갑작스러운 찢어지는 듯한 가슴 통증과 호흡곤란으로 응급실에 내원함. 흉부 X-ray 상 기흉과 심비대 소견이 관찰되었으며, D-dimer 수치가 2500 ng/mL로 상승됨. 부친의 흉부 대동맥류 수술 가족력이 있음.

2. Top 1 진단 근거

가족성 흉부 대동맥류 및 대동맥 박리(FTAAD)가 최우선 고려 대상임. 환자의 주요 증상인 급성 흉통(HP:0002107)과 호흡곤란(HP:0001640)은 FTAAD의 전형적인 증상임. 또한 부친의 흉부 대동맥류 수술 이력은 가족성 발생을 시사함. D-dimer 상승(2500 ng/mL)은 대동맥 박리를 강하게 시사하는 소견임. 상지 부종(HP:0001903)이나 연하곤란(HP:0002264)이 없는 점은 초기 단계의 FTAAD와 일치함.

3. 감별 진단

원발성 자발성 기흉은 흉부 X-ray 상 기흉 소견으로 인해 고려되나, 가족력과 D-dimer 상승이 설명되지 않아 덜 가능성 있음. 가족성 비대심근병증은 심비대 소견과 일치하나, 급성 흉통과 호흡곤란의 갑작스러운 발병을 설명하기 어려움. 그러나 FTAAD와 연관될 수 있어 추가 평가가 필요함.

4. RAG 근거

FTAAD(ORPHA:91387)는 내부 DB와 외부 API 간 유전자 정보 불일치로 추가 확인이 필요함. 내부 DB는 ACTA2, MYH11, TGFB1, TGFB2, FBN1을 원인 유전자로 제시하나, Monarch API에서는 관련 유전자를 찾지 못함.

PubCaseFinder는 20개의 관련 유전자를 제시함. Monarch의 질병 정의는 환자

의 임상 양상과 일치함. 유병률, 발병 연령 등의 역학 정보는 API에서 제공되지 않아 추가 조사가 필요함.

5. 케이스 비교

FTAAD에 대한 직접적인 케이스 리포트는 제공되지 않았으나, 원발성 자발성 기흉 사례(PMID: 41960001)와 비교 시 본 환자는 나이가 더 많고(42세 vs 22세) BMI 정보가 없어 직접 비교가 어려움. 또한 본 환자는 기침이나 재채기 같은 명확한 유발 요인 없이 증상이 발생했으며, 가족력이 있다는 점에서 차이가 있음.

6. 역학 정보

가족성 흉부 대동맥류 및 대동맥 박리(FTAAD)의 정확한 유병률과 발병 연령은 제공된 데이터에서 확인할 수 없음. 그러나 일반적으로 희귀질환으로 분류되며, 가족력이 있는 경우 조기 발병 가능성이 높음. 유전 양식은 주로 상염색체 우성으로 알려져 있음.

권고사항

즉각적 검사

- 흉부 CT 혈관조영술
- 심장초음파검사
- 유전자 검사 (ACTA2, MYH11, TGFB1, TGFB2, FBN1)

전문과 의뢰

- 심장혈관외과 전문의 상담 (가족성 흉부 대동맥류 및 대동맥 박리 의심)
- 다학제 진료팀(MDT) 의뢰 (희귀질환 ORPHA:91387 의심)

치료 가이드라인

- [가족성 흉부 대동맥류 및 대동맥 박리] 베타차단제 투여 및 수술적 치료 고려 (출처: General medical consensus)
- [원발성 자발성 기흉] 흉관 삽입술 또는 단순 흡인술 고려 (PMID: 24734096)
- [가족성 비대심근병증] 베타차단제 또는 칼슘채널차단제 투여, 심실중격절제술 고려 (PMID: 40691641)

유전자 검사

- ACTA2, MYH11, TGFB1, TGFB2, FBN1 (복수 소스 확인)
- FLCN

- MYH7, CAV3, MYLK2

추가 검사

- 트로포닌 I 연속 측정
- NT-proBNP
- 혈액 가스 분석

임상시험

- 현재 모집 중인 적합한 임상시험이 없음

신뢰도 지표

- 전체 신뢰도: 0.70
- 근거: 내부 DB와 외부 API 간 유전자 정보 불일치가 있으나, 환자의 임상 증상과 가족력이 FTAAD와 높은 일치도를 보임. 그러나 특정 유병률, 발병 연령 등의 역학 정보가 부족하여 완전한 확신을 갖기 어려움.
- 유전체 근거: Medium | 케이스 매칭: High | 임상시험: Low

AI 결과는 진단 보조이며 최종 진단은 주치의의 임상 판단과 추가 검사 결과를 종합하여 확정합니다.